

Plan terapéutico y reevaluación funcional

Formato independiente de registro | Documento asociado: 05-P03

1. Finalidad y momento de uso

Utilizar para registrar plan terapéutico y reevaluación funcional. Revisar el documento asociado antes de diligenciar y registrar la ejecución del proceso correspondiente, no su programación como si ya se hubiera realizado. El formato se entrega vacío; no valida por sí solo cumplimiento de habilitación.

2. Instrucciones por campo

Campo	Cómo diligenciar
Paciente	Comprobar identidad y registrar solo datos necesarios. Mantener reserva y vinculación al expediente autorizado.
Diagnóstico y problema funcional	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Medida de línea base	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Objetivo acordado	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Intervenciones	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Frecuencia y justificación	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Criterio de progresión	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Fecha y medida de reevaluación	Consignar la fecha y hora reales o el periodo completo; no anticipar ejecución ni reconstruir hechos sin identificación de la fuente.
Resultado y ajuste	Usar datos observados, fuente y unidad. Si no se puede calcular o falta evidencia, registrar pendiente y explicar.
Autor y autenticación	Vincular el soporte auténtico del autor o decisión. Un nombre digitado aislado no reemplaza la autenticación exigible.

3. Control del registro

Completar datos observados, unidades y soportes. No dejar blancos ambiguos en el registro utilizado: escribir no aplica con razón cuando corresponde. Corregir con anotación trazable, preservando original, fecha y autor; no borrar ni rellenar retrospectivamente. Los campos de identidad y decisión se conservan bajo acceso autorizado.

Registro principal

Fecha y lugar de ejecución: _____
Referencia de episodio, equipo o lote: _____

Paciente	
Diagnóstico y problema funcional	
Medida de línea base	
Objetivo acordado	
Intervenciones	
Frecuencia y justificación	
Criterio de progresión	
Fecha y medida de reevaluación	
Resultado y ajuste	
Autor y autenticación	

Vincular los soportes auténticos al archivo correspondiente. Los nombres se completan solo al ejecutar; el encabezado permanece libre para personalización. No hay firmas ficticias ni aprobación preestablecida.

Continuación, novedades y comprobación

Repetir para los hechos que requieren continuidad o una segunda observación. Mantener referencia al registro principal; no usar esta página para ocultar cambios del original.

Fecha y referencia	Dato / actividad observada	Resultado / soporte

Novedad, acción y seguimiento

Novedad y riesgo observado	
Acción inmediata y responsable	
Medida preventiva, plazo y soporte	
Verificación de resultado y eficacia	
Autor o ejecutor y referencia de autenticación	

Reserva y autenticación

La ausencia de casillas de firma no elimina firma o autenticación exigibles, en particular de historia y consentimiento. Incorporar el soporte válido antes del uso asistencial. No aplicar una decisión clínica con un formato de aceptación incompleto. Referencia: 05-P03; criterios 11.1.6 y 11.3.1.27-28: historia y registros; Resoluciones 1995/1999, 839/2017, Ley 1581/2012 y consentimiento conforme a Ley 528/1999 y reglas particulares.

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576